

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	子宮內膜異位症 Endometriosis				
編號	A31000-Q03-W-M08	制定者	R9 黃麗華	公布日期	100 年 08 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.0 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解子宮內膜異位症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

子宮內膜組織生長到子宮外，在子宮外到處散佈，當每次月經來潮時，體內賀爾蒙會刺激卵巢內的子宮內膜組織，因為囊腫內黏稠液體及顏色類似巧克力，故稱為巧克力囊腫，若生長在子宮肌肉層即稱為子宮腺肌症，或是生長在輸卵管、子宮外壁、腹膜、腸道、膀胱或開刀的傷痕，甚至有可能生長到肺部，這些子宮內膜組織會隨著體內月經週期荷爾蒙改變而有像月經週期般的變化。

（二）症狀

1. 經痛及骨盆腔疼痛：並非所有女性都會有此症狀，若囊腫破裂時則會造成急性骨盆腔劇烈疼痛。
2. 不孕：子宮內膜組織異位侵犯到輸卵管，造成輸卵管水腫沾粘不通。
3. 性交疼痛或出血。
4. 月經來前點狀出血或經血過多。
5. 手術疤痕組織週期性疼痛或出血：子宮內膜組織異位侵犯到手術疤痕組織，引起局部腫塊疼痛或出血。

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	2/11

6. 週期性咳血或流鼻血：子宮內膜組織異位侵犯到鼻腔黏膜或肺部。

7. 非特異性症狀，如血尿、解尿疼痛、排便疼痛。

(三) 常見檢查

一般常見的檢查，其敘述如下：

1. 觸診：腹部觸診時，單側或雙側卵巢腫塊會固定不動；陰道、直腸內診時，會有子宮薦骨韌帶結節或子宮直腸陷凹處有壓痛之情形。
2. 抽血檢驗：檢驗血液中的卵巢瘤指數(CA-125)，平常 CA-125 不會釋放至血液中，直到組織受損或有異常的組織細胞增生時，血液中的 CA-125 便會有升高之情形，若有升高情形可懷疑有子宮內膜異位症。
3. 超音波檢查：為第一線的診斷工具，可偵測出體內腫瘤的位置，若中重度的子宮內膜異位症會造成子宮增大可以藉由超音波檢查得知，但輕度而未造成腫瘤的子宮內膜異位症則有可能無法從超音波得知了。腹部超音波檢查需於檢查前先漲尿有助顯像；陰道超音波檢查則於檢查前排空膀胱。
4. 腹腔鏡檢查：唯一能確立診斷的方法。在麻醉下於腹部處打 2-4 個 0.5 至 1 公分的小孔，以伸入攝影機及手術器械，可以清楚看到腹腔內狀況，即使是輕度子宮內膜異位症，也可以診斷出，若有病變亦可順便手術處理。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：無法完全消除病灶，僅能阻止病灶蔓延或增生的維持療法或是作為手術後之輔助療法。
 - (1) 黃體素：每天服用 2-3 次，連續服用 3-6 個月。作用機轉使子宮內膜異位症病灶萎縮；副作用有間歇性出血、水腫、體重上升、乳脹、多毛症等；禁忌懷孕婦女勿服用會造成女嬰男性化。
 - (2) 避孕藥：每天 1 次，連續服用 9 個月。作用機轉使子宮內膜異位症病灶萎縮；副作用有嘔心感、間歇性出血、水腫、體重上升等，禁忌懷孕婦女勿服用會造成女嬰男性化。

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	3/11

(3)療得高(Danazol)：是一種合成的男性賀爾蒙，每天服用 2-4 次，需於手術後服用 3-6 個月。作用機轉抑制腦下垂體釋放及合成濾泡刺激素(FSH)和黃體素生成素(LH)的能力，減少子宮內膜異位症復發，這是一種強力的黃體素，可造成假性懷孕的現象，使得月經停止，約有 70-90%的子宮內膜異位症病人獲得改善；副作用有長青春痘、發胖、毛髮增加、聲音低沉等，停藥後大多數副作用會消失；禁忌懷孕婦女勿服用會造成女嬰男性化。

(4)性腺刺激素釋放素協同劑(GnRHa、Leuplin)：每個月皮下注射 1 次，手術後注射 3-6 個月。作用機轉從腦下垂體直接抑制性腺刺激素分泌，造成假性停經的現象，而達到減少子宮內膜異位症復發；副作用有臉潮紅、頭痛、失眠、陰道乾澀等；禁忌為懷孕婦女勿服用會造成女嬰男性化、哺乳者、對 GnRHa 過敏者等。

(五) 手術治療

手術是唯一可能去除病灶的有效治療，讓病灶不再擴大及維持卵巢功能。手術方式可分為腹腔鏡及開腹手術，而手術治療後的再發率約 20%，所以後續的預防治療是很重要的。若未生育過或仍想保留生育能力且為症狀為輕、中度的病人，摘除病灶後仍會盡量保留卵巢及子宮；若是早婚已生或子宮內膜異位症嚴重則切除子宮、卵巢。

1. 腹腔鏡手術：用於診斷及治療，其原理為使用電燒去除散布各處的子宮內膜異位組織、沾黏、異位瘤等，此手術的優點有手術後傷口小、復原較迅速、縮短住院日；此手術在肚臍下緣及下腹部處開 2-4 個約 1-2 公分的小洞，打入二氧化碳，將肚子鼓脹起來，再放入腹腔鏡儀器清除病灶；手術後腹部有 2-4 個約 1-2 公分傷口，需拆線，通常於出院後第一次回診拆線。此手術有可能會在腹部放置 1 條引流管，引流腹內血水，一般引流液量約 <50ml/天可依醫囑移除之。
2. 開腹手術：因散布各處的子宮內膜異位組織範圍較廣泛、沾黏嚴重、異位瘤太大且有可能為惡性之虞，或是腹腔鏡手術不易進行，故會考慮行此手術治療；手術後下腹部有一橫式或直式的傷口，約 10-15 公分。橫式傷口無需拆釘；直

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	4/11

式傷口因外層採釘子固定，故需拆釘，一般視傷口癒合情況約手術後 5-7 天拆半釘，另一半釘通常於隔天或數天後回門診再拆。

(六) 護理問題

1. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關。
2. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。
3. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。

(七) 護理措施

1. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關。
 - (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
 - (2) 鼓勵及引導病人說出心中的感受和想法，以及目前不適的症狀，並給予適當的醫療處置及護理。
 - (3) 運用同理心，耐心地傾聽病人心中的感受和想法，尋找引起焦慮的原因。
 - (4) 主動提供正確的疾病及治療的相關資訊給病人，適時地澄清及修正其錯誤的觀念，以減輕病人的焦慮感。
 - (5) 執行醫療處置或護理照護前，應給予詳細解釋其準備工作及注意事項，並提供衛教單張閱讀，以減輕病人的不安感。
 - (6) 執行醫療處置或護理照護時，應注重病人之隱私，勿過度裸露病人身體隱私部位，必要時用屏風遮擋，請異性迴避。男性醫師幫女性病人做婦科檢查時，女性護理人員應要陪同在旁。
 - (7) 利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧（如按摩）、冥想等，以減輕焦慮。
 - (8) 轉移病人注意力，如聽音樂、聊天。
 - (9) 教導病人手術後咳嗽、翻身、下床活動時，如何固定傷口，減少傷口疼痛，且會依當時疼痛程度給予控制疼痛的處置，以減輕病人害怕傷口疼痛之焦慮。
 - (10) 讓病人瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，以減少焦慮。

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	5/11

(11)介紹相同的病人，彼此經驗分享。

(12)多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減少焦慮。

(13)隨時評估病人焦慮改善狀態。

(14)若病人焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療，如：鎮靜、精神神經安定劑。

2. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。

(1)評估病人的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沉或表淺），並記錄疼痛的變化。

(2)監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。

(3)與病人或家屬確認引發疼痛的因素，如個人的、與疾病有關的、與治療有關的。

(4)與病人或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。

(5)評估病人使用疼痛控制方法的意願，在病人選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。

(6)教導病人疼痛時採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥勢。

(7)鼓勵病人運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。

(8)教導病人放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天，以減緩疼痛。

(9)教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。

(10)避免腹部用力，如哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。

(11)多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

3. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。

(1)每班監測傷口滲出液之顏色、氣味、濃稠度及癒合情況。

(2)每班監測引流液之量、顏色、氣味、性質及周圍皮膚之完整性。

(3)監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。

(4)教導病人或主要照顧者炎症症狀，如紅、腫、熱、痛及徵象，如發燒、流膿，

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	6/11

若有以上之情形應通知醫護人員。

- (5)教導病人或主要照顧者引流管勿高於放置或穿刺部位，維持引流管之通暢，並教導及協助翻身或活動方式，避免壓迫引流管。
- (6)教導病人或主要照顧者預防感染的方法，如接觸病人前洗手、保持傷口清潔及乾燥、避免壓迫傷口、注意衛生、營養充足等，並評估其瞭解程度。
- (7)視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。
- (8)若病人情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。
- (9)建議採少量多餐，以增進食量，必要時依醫囑給予維他命、營養素或適量輸液。
- (10)評估病人營養狀況，給予飲食衛教。

(八) 衛教指導

1. 飲食方面

- (1) 一般而言，採腹腔鏡手術於手術後，視醫囑禁食 8 小時；開腹手術視醫囑禁食至排氣，或有腸蠕動時，依醫囑可進食。
- (2) 可以開始進食時，應先喝白開水約 30-50c.c.，若無噁心、嘔吐腹脹、腹痛、腸絞痛後，可吃白飯、新鮮自烹白稀飯、麵條等軟質飲食，勿吃太快太多，避免腸絞痛。沒有任何不適時，可以恢復正常飲食，採少量多餐，不要太油膩及太鹹。
- (3) 建議病人 1 週內少攝取刺激性食物如辣椒、咖啡；少進食易產氣食物如牛奶、蛋、豆類製品、地瓜、麵包等，以防腹脹不適；增加水份攝取，以避免便秘；建議 2 週內避免進食含人參、麻油、酒等食物，避免影響傷口癒合。

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	7/11

2. 傷口方面

- (1) 衛教腹腔鏡手術後腹部會有 2-4 個小傷口，或是開腹手術後會有 1 個約 10-15 公分橫式或直式傷口，且必要時醫師有可能會放置傷口引流管，可能會引起身體不適。
- (2) 每班觀察傷口有無紅、腫、熱、痛，或不正常的分泌物及傷口恢復狀況。
- (3) 手術後當天不會換藥，手術後第三天會由醫師換藥，之後每 2 天換藥一次，或視當時傷口情況換藥。
- (4) 換藥步驟及方法：採無菌技術換藥，消毒完畢後再以無菌紗布或無菌敷料覆蓋傷口及黏貼好。
- (5) 教導病人需保持傷口及周圍皮膚清潔與乾燥。
- (6) 教導腹部傷口約 10-14 天癒合，需保持清潔乾燥。
- (7) 出院後建議傷口約 2-3 天換藥，或是不小心弄濕或滲濕時應更換之。

3. 傷口疼痛方面

- (1) 教導在傷口換藥後或下床時使用束腹帶，減少腹部傷口牽扯，減輕傷口疼痛。
- (2) 衛教 4-6 週內避免提重物，若需提 5 公斤以上重物時，建議可使用束腹帶固定傷口，以避免疼痛。

4. 活動方面

- (1) 衛教手術後當天在床上應多翻身或側臥，最好每 2 小時翻身一次，促進血液循環，增加腸蠕動，以預防腸道粘連，並鼓勵病人早期下床活動。
- (2) 手術後第二天盡可能採漸進式下床活動，可以先採半坐臥，若未感不適則可以採坐臥，再坐於床邊，慢慢站起走動，全程需由家屬或朋友陪伴，以防止跌倒之虞。
- (3) 衛教避免長時間坐或站、勿激烈運動，如機車、騎腳踏車、開車長途旅行、爬山、游泳。

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	8/11

5. 衛生方面

- (1) 手術後導尿管會留置大約 1 天，導尿管留置期間會給予會陰沖洗及導尿管的護理，並視情況協助移除導尿管。移除尿管後，需注意第一次解尿時間（4-6 小時內自解）及記錄排尿量與觀察尿液顏色。
- (2) 手術後若陰道有血狀排泄物，應勤換棉墊，以保持乾淨，避免感染。
- (3) 如廁後衛生紙應由前往後擦拭，勤換棉墊，避免感染。
- (4) 病人身體清潔之照護，手術後先以擦拭方式為主，醫師會視傷口癒合狀況，評估是否可以開始沐浴。若可以沐浴時，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道灌洗，以避免傷口感染。

6. 性方面：需在醫師診察傷口癒合後，視情況約 2-6 週可恢復性生活。

7. 其他方面：

- (1) 跟病人衛教術後會有肋骨及肩部酸痛不適情形，約會持續 2-3 天。
- (2) 出院後若有以下情形應立即回診：傷口有紅、腫、熱、痛及滲出液情形；體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 以上；解尿困難、疼痛、頻尿、有灼熱感；陰道出血量多呈鮮紅色、惡臭。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	9/11

六、參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲(2020)．*產科護理學*（十版），新文京。
- (二) 賴玉琪(2022)．淺談子宮內膜異位症．*嘉基藥訊*，161，5-8。
- (三) 鍾凱丞、張燕後(2020)．無性經驗的女性發現輸卵管卵巢膿瘍合併子宮內膜異位．*婦癌醫學期刊*，52，6-10。
- (四) Song, S.Y., Jung, Y. W., Shin, W., Park, M., Lee, G. W., Jeong, S., An, S., Kim, K., Ko, Y. B., Lee, K. H., Kang, B. H., Lee, M., and Yoo, H. J. (2023). Endometriosis-Related Chronic Pelvic Pain. *Biomedicines*, 11(10), 1-15.

七、附件

(略)

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.31	1.0	新制定。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	1.1	1.醫護部改護理部。 2.修改錯別字。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	2.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	2.2	更新第六項文獻參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	2.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	2.4	第七目之 1(2)內容修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	2.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 1(2)(3)新增說明內容。 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	2.6	1. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。

主題名稱	子宮內膜異位症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M08	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.07	2.6	1. 年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.7	1. 第三項第一、四、五、八目說明內容修訂。 2. 第三項第六、七目之護理問題名稱修訂。 3. 第六項參考資料修訂。 4. 刪除內文參考文獻。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	2.8	第三項第一目說明內容修訂。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	2.9	第三項第一、四、五目說明內容修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.0	第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。